

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

1. Las sombras de Gümprich observadas en sangre periférica son típicas de:
A) Leucemia prolinfocítica
B) Leucemia linfática crónica
C) Tricoleucemia
D) Leucemia de linfocitos grandes granulares
2. La vida media de una plaqueta en circulación está entre:
A) 1 y 2 días.
B) 8 y 13 días.
C) 15 y 18 días.
D) 27 y 30 días.
3. El cromosoma Filadelfia (Ph) es característico de:
A) Leucemia linfática crónica.
B) Leucemia aguda mieloblástica.
C) Leucemia mieloide crónica.
D) Leucemia aguda monolítica.
4. El mieloma múltiple es una proliferación clonal de:
A) Neutrófilos.
B) Linfocitos T.
C) Células plasmáticas.
D) Mielocitos.
5. La plaqueta procede del:
A) Megaloblasto.
B) Megacariocito.
C) Trombocito.
D) Mieloblasto
6. La adhesión de las plaquetas a los neutrófilos se denomina:
A) Satelitismo.
B) Superposición.
C) Agregación.
D) Anisocitosis trombocitaria.
7. ¿Cuál no es una característica de las células plasmáticas?
A) Puede contener vacuolas.
B) Su citoplasma es muy basófilo.
C) Su núcleo es grande.
D) Son redondeadas u ovaladas.
8. Célula de 15 a 20 micras con núcleo redondo que ocupa gran parte de la célula, con nucléolos, escaso citoplasma de color azul y carente de granulaciones
A) Mielocito.
B) Metamielocito.
C) Promielocito.
D) Mieloblasto.
9. Qué elementos no son propios del sistema retículo endotelial
A) Macrófagos.
B) Megacariocitos.
C) Fibras de reticulina.
D) Células reticulares.
10. Al ir madurando los blastos:
A) Aumentan de tamaño.
B) Su cromatina se va apilando.
C) Su citoplasma se haciendo más pequeño.
D) Su citoplasma se va haciendo más basófilo.
11. ¿En cuál de las siguientes circunstancias suele haber monocitosis?
A) Síndrome de Cushing.
B) Infecciones granulomatosas.
C) Tratamiento con esteroides.
D) Tricoleucemia.
12. Los blastos suelen contener bastones de Auer en la:
A) Leucemia mieloide crónica.
B) Leucemia linfocítica aguda.
C) Leucemia linfocítica crónica.
D) Leucemia mieloide aguda.
13. En el examen de un frotis de sangre periférica de un paciente, se observaron linfocitos activados de



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

un tamaño más grande que los linfocitos normales, con citoplasma abundante y cromatina nuclear más laxa. ¿Que sugiere este hallazgo?

- A) Leucemia mieloide crónica.
- B) Viriasis.**
- C) Leucemia linfocítica crónica.
- D) Sepsis bacteriana.

14. ¿En qué procesos se encuentran las células de Reed-Sternberg?:

- A) Linfoma de Hodgkin.**
- B) Linfoma no Hodgkin.
- C) Linfoma de Burkitt.
- D) No existen en los linfomas

15. Sólo una de las siguientes causas de trombocitopenia es de origen inmune:

- A) Púrpura trombopénica idiopática.**
- B) Hiperesplenismo.
- C) CID.
- D) Púrpura trombótica trombocitopénica

16. ¿Cuál de las siguientes no es una alteración morfológica de los granulocitos?

- A) Cuerpos de Dohle.
- B) Anomalia de Pelger - Huet
- C) Cuerpos de Howell - Holly.**
- D) Granulación tóxica.

17. ¿Cómo se llama el descenso severo de los leucocitos que se acompaña de anemia y trombopenia?

- A) Leucopenia.
- B) Granulocitopenia.
- C) Agranulocitosis.
- D) Pancitopenia.**

18. Mediante la utilización de plaquetas marcadas con ^{51}Cr ó ^{111}In , podemos:

- A) Realizar un estudio de la integridad vascular
- B) Establecer la vida media plaquetaria (VN.: 8-10 días)**

- C) Hacer un seguimiento del recorrido plaquetar
- D) Establecer la vida media plaquetaria, salvo consumo por sangrado (V.N.: 10-15 días)

19. Tenemos un paciente que en su analítica el recuento plaquetario es inferior a 125.000 / mm³. Esta trombopenia se podría deber a:

- A) Descenso en la producción de plaquetas.
- B) Aumento en la destrucción de plaquetas.
- C) Esplenomegalia.
- D) Todas las anteriores son ciertas.**

20. Qué podemos decir de un niño de 4 años que tiene un recuento de leucocitos de 10.000 / mm³ y cuya fórmula leucocitaria es: neutrófilos 30%, linfocitos 60%, monocitos 7%, eosinófilos 2% y basófilos 1%.

- A) Existe leucocitosis.
- B) Existe linfopenia.
- C) Es normal.**
- D) Existe neutropenia.

21. En el laboratorio de hematología puede producirse una pseudotrombopenia cuando se utiliza como anticoagulante para su recuento en tubo:

- A) Citrato.
- B) Heparina.
- C) Calcio.
- D) EDTA.**

22. Ingresar un niño por urgencias con fiebre, adenopatías y dolor de cabeza. Se pide al laboratorio un frotis en el que se observan linfocitos atípicos, acompañado de leucocitosis. El estudio serológico es positivo para VEB (virus del Epstein-Barr) ¿De cuál de las siguientes enfermedades podría tratarse?

- A) Leucemia mieloide crónica.
- B) Anemia hemolítica post- transfusional.
- C) Mononucleosis infecciosa.**
- D) Leucemia linfocítica crónica.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

23. Para el recuento de leucocitos ¿cuál de estas opciones puede ser causa de error en el resultado analítico?
- A) La aplicación prolongada del torniquete.
- B) No afecta el tiempo transcurrido después de ejercicio y comida.
- C) Que el anticoagulante utilizado altere poco la morfología celular.
- D) Todas las respuestas son correctas.
24. ¿Qué porcentaje de los leucocitos de la sangre representan los basófilos?
- A) 0-0'5%
- B) 2-5%
- C) 5-10%
- D) 10-15%
25. En la tricoleucemia, ¿Qué tipo de células están aumentadas?
- A) Células linfoides
- B) Blastos
- C) Basófilos
- D) Monolitos
26. ¿Cuál es el método más sensible para detectar enfermedad mínima residual en una leucemia mieloide crónica?
- A) Citogenética
- B) Citometría de flujo
- C) FISH
- D) Biología molecular
27. Respecto a la función de las plaquetas que afirmación no es cierta:
- A) Previenen la salida de sangre de los vasos
- B) Su única función es constituir el trombo plaquetario
- C) Contienen diversos factores que intervienen en la coagulación
- D) Su déficit produce una tendencia al sangrado
28. Cuando hablamos de trombopenia, decimos que:
- A) Las plaquetas son superiores a 50.000/ μ l
- B) Las plaquetas son inferiores a 150.000/ μ l
- C) Las plaquetas están entre 200.000 y 400.000/ μ l
- D) Todas las respuestas anteriores son correctas
29. Entre las causas de una trombocitosis autónoma, se encuentra;
- A) Deficiencia de hierro.
- B) Trastorno mieloproliferativo (policitemia vera, mielofibrosis, leucemia mieloide crónica).
- C) Esplenectomía.
- D) Enfermedad inflamatoria.
30. Señale el tiempo de permanencia de las plaquetas en la sangre periférica:
- A) 8-12 días.
- B) 20-22 días.
- C) 15-20 días.
- D) 25-30 días.
31. Las células plasmáticas son células del sistema inmunológico cuyo papel consiste en la secreción de anticuerpos. ¿Cuál es la célula precursora de las células plasmáticas?:
- A) Linfocitos B
- B) Linfocitos T
- C) Linfoblastos.
- D) Monocitos.
32. ¿De qué tipo de leucemia es característico el cromosoma Filadelfia?:
- A) Linfática crónica.
- B) Aguda mielocítica.
- C) Mieloide crónica.
- D) Aguda monocítica.
33. Si decimos que un leucocito es un fagocito lo estamos clasificando según su:
- A) Origen.
- B) Función.
- C) Morfología.
- D) Método de tinción.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

34. La principal función de los neutrófilos es:

- A) La vigilancia inmunitaria.
- B) El control de las infecciones parasitarias.
- C) El control de las reacciones anafilácticas.
- D) La fagocitosis.**

35. Los granulocitos basófilos presentan un diámetro de:

- A) 12-14 micras.**
- B) 10-12 metros.
- C) 5-6 mm.
- D) 3-8 micras.

36. El citoplasma de los monocitos presenta:

- A) Un tono rosado.
- B) Cromatina condensada en aspás.
- C) Vacuolas fagocíticas.**
- D) Todas son ciertas.

37. Hablamos de una monocitosis cuando el recuento de monocitos en sangre periférica es:

- A) 3500 /mm³.**
- B) 500 /mm³.
- C) 900 /mm³.
- D) Ninguna es cierta.

38. Los linfocitos basófilos aparecen en pacientes con:

- A) Infecciones víricas.**
- B) Infecciones bacterianas.
- C) LMA.
- D) LLC.

39. Un paciente que presente una policitemia presentará un hematocrito:

- A) Aumentado.**
- B) Disminuido.
- C) Normal.
- D) Todas son ciertas.

40. ¿Cuál de los siguientes no es uno de los gránulos de las plaquetas?

- A) Lisosomas.
- B) Gránulos alfa.
- C) Proteosomas.**
- D) Gránulos densos.

41. El núcleo de los linfocitos:

- A) Es redondeado.**
- B) Presenta lobulaciones.
- C) Siempre aparece en un número par.
- D) Todas son ciertas.

42. La célula de Reed-Sternberg es típica del:

- A) Linfoma de Hodgkin.**
- B) Linfomas no Hodgkin.
- C) Mieloma múltiple.
- D) Leucemia linfoide aguda.

43. En las leucemias, el criterio de clasificación FAB, se basa en:

- A) El origen.
- B) El fenotipo.
- C) La morfología.**
- D) Los Ag (antígenos) de superficie.

44. El cromosoma Filadelfia se presenta habitualmente en:

- A) Linfoma no Hodgkianos.
- B) Leucemia linfoide crónica.
- C) Leucemia mieloide crónica.**
- D) Tricoleucemia.

45. El corpúsculo de Barr tiene forma de palillo de tambor y se observa en pequeño porcentaje:

- A) En los polimorfonucleares eosinófilos.
- B) En los polimorfonucleares neutrófilos.**
- C) En cualquier leucocito con tinciones especiales para DNA (Acido Desoxirribonucleico).
- D) En cualquier leucocito en metafase.

46. La tinción de la peroxidasa es negativa en los:

- A) Neutrófilos.
- B) Monocitos.
- C) Linfocitos.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

D) Basófilos.

47. El índice de Fosfatasa alcalina granulocitaria (FAG) es útil para diferenciar:

A) Leucemia mieloide crónica subclase M1 de la subclase M2.

B) Leucemia mieloide crónica subclase M6 de la subclase M7.

C) Leucemia mieloide aguda de reacciones leucemoides.

D) Leucemia mieloide crónica de reacciones leucemoides.

48. Los cuerpos de Döhle con coloraciones panópticas se observan como:

A) Inclusiones en forma de agujas de color rojo violáceo.

B) Inclusiones ovaladas, excéntricas, de color azul pálido.

C) Inclusiones grandes, redondeadas y excéntricas con halo.

D) Gruesos gránulos azurófilos irregulares.

49. Un aumento del número de neutrófilos en cayado o en banda se conoce como:

A) desviación a la derecha.

B) desviación a la izquierda.

C) pseudoneutrofilia.

D) Neutrofilia inicial.

50. La tinción con fosfatasa ácida tartrato- resistente es útil en el diagnóstico de:

A) Mieloma múltiple.

B) Leucemia mieloide crónica.

C) Leucemia linfocítica aguda.

D) Tricoleucemia.

51. Como marcadores inmunológicos de los linfocitos se suelen usar:

A) CD19 para los linfocitos B y CD3 para los linfocitos T.

B) CD17 para los linfocitos B y CD5 para los linfocitos T.

C) CD24 para los linfocitos B y CD9 para los linfocitos T.

D) CD9 para los linfocitos B y CD24 para los linfocitos T.

52. Para el recuento automatizado de plaquetas cuando su número es inferior a $20 \times 10^9/L$ se recomienda el empleo de:

A) Dispersión lumínica.

B) citometría de flujo.

C) impedancia.

D) dispersión lumínica con dos ángulos de lectura.

53. La excreción urinaria de proteínas de Bence Jones se asocia generalmente con:

A) Estados de deshidratación

B) Enfermedad viral citomegálica

C) Gammapatía de cadenas pesadas

D) Mieloma múltiple

54. ¿Cuál de las siguientes poliglobulias es verdadera y primaria?:

A) Poliglobulias hipoxémicas.

B) Policitemia vera.

C) Poliglobulias por hipoxia citotóxica.

D) Poliglobulias por hipoxia local renal.

55. Fórmula leucocitaria realizada mediante método manual. Señala la respuesta correcta:

A) Los valores normales no varían con la edad.

B) Incluye cuatro poblaciones linfocitarias.

C) La tinción preferible es la tinción de May-Grunwald-Giemsa.

D) Todas las respuestas son incorrectas.

56. Con respecto a la anomalía de Pelger-Hüet señala la respuesta correcta:

A) Puede aparecer en algunos síndromes mielodisplásicos.

B) Es una alteración del núcleo de los neutrófilos.

C) Es una alteración del citoplasma de los linfocitos.

D) Todas las respuestas son falsas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

57. Con respecto al mieloma múltiple señala la respuesta correcta:

- A) Es la gammapatía monoclonal más frecuente.
- B) Las plaquetas están aumentadas.
- C) En el frotis pueden observarse eritroblastos.
- D) Las respuestas a y c son correctas.**

58. Respecto al síndrome mieloproliferativo crónico, un recuento de leucocitos muy elevado, fosfatasa alcalina granulocítica disminuida, cromosoma Ph positivo, hematocrito normal o disminuido, son datos típicos de:

- A) Leucemia mieloide crónica.**
- B) Policitemia Vera.
- C) Mielofibrosis.
- D) Trombocitosis esencial.

59. ¿Qué característica de las siguientes es más típica de las células de la leucemia linfática crónica que de las células de la leucemia linfoblástica aguda?

- A) Basofilia citoplasmática.
- B) Existencia de nucleolos.
- C) Cromatina nuclear condensada.**
- D) Vacuolas citoplasmáticas.

60. ¿De qué célula de sangre periférica se origina la célula plasmática?

- A) Linfocito CD4 (colaborador).
- B) Linfocito CD8 (citotóxico).
- C) Linfocito B.**
- D) Monocito.

61. ¿Cuál es la causa más frecuente de basofilia?

- A) Enfermedades alérgicas.
- B) Síndromes mieloproliferativos crónicos.**
- C) Infecciones.
- D) Síndromes mielodisplásicos.

62. ¿Qué células son positivas para la naftol-AS-D-acetato-esterasa que es inhibida por el fluoruro sódico?

A) Monocitos.

- B) Linfocitos.
- C) Neutrófilos.
- D) Eosinófilos.

63. En un paciente en el recuento automático de plaquetas es repetidamente bajo y en la extensión se ven agregados plaquetarios, ¿qué actitud sería la aconsejable?

A) Calentar la muestra a 37° Centígrados y reanalizar.

B) Repetir extracción utilizando como anticoagulante el citrato sódico.

- C) Agitar bien la muestra y reanalizar.
- D) Ninguna de las anteriores.

64. En la tricoleucemia. ¿Qué tipo de células están aumentadas?:

A) Células linfoides.

- B) Blastos.
- C) Basófilos.
- D) Monocitos.

65. Paciente con anemia, proteínas plasmáticas altas, alteraciones óseas y renales, y pico monoclonal en la proteinograma. En la extensión de sangre periférica se observan eritrocitos formando "pilas de moneda". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

A) Infección vírica.

B) Mieloma múltiple.

- C) Leucemia linfática crónica.
- D) Mononucleosis infecciosa.

66. ¿Qué alteración de los leucocitos se produce en las infecciones parasitarias?:

A) Eosinopenia.

B) Eosinofilia.

- C) Basopenia.
- D) Basofilia.

67. Puede haber aparición de neutropenia en:

A) Anemia aplásica.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

B) Anemia megaloblástica.

C) Hepatitis vírica.

D) Todas son ciertas.

68. Las leucemias se dividen en agudas y crónicas dependiendo de:

A) Grado de diferenciación de células neoplásicas.

B) Número de células malignas.

C) De la agresividad de las células neoplásicas.

D) A y C son correctas

69. La presencia de células de Redd Sternberg:

A) Permite el diagnóstico de la enfermedad de hodgkin.

B) Se encuentran en las leucemias mieloides agudas.

C) Se encuentran en la anemia sideroblástica.

D) Se encuentran en las leucemias mieloides crónicas.

70. De la electroforesis en soporte sólido para diagnosticar las Gammopatías Monoclonales (GM) señale lo cierto:

A) Es recomendable procesar plasma en lugar de suero.

B) Un estudio analítico correcto de las GM debe analizar muestras de suero y de orina.

C) El gel de agarosa es el soporte recomendado.

D) B, y C son ciertas.

71. La Inmunofijación de proteínas es de utilidad en:

A) La identificación de proteínas específicas.

B) Sólo en la electroforesis de proteínas del líquido cefalorraquídeo.

C) Sólo en proteínas de bajo peso molecular.

D) En todos los anteriores.

72. Ante un paciente con sospecha diagnóstica de leucemia linfática crónica, debemos tener presente que:

A) Es fundamental el análisis del marcador de linfocitos B CD5

B) Es principalmente de origen linfoide NK

C) Es fundamental el análisis del marcador de linfocitos T CD8

D) Es fundamental el análisis del marcador de linfocitos T y B CD8

73. Considerando la célula más inmadura la situada al inicio de la relación, la secuencia de maduración normal de las plaquetas es:

A) Megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito y plaquetas.

B) Megacariocito, promegacarioblasto, megacarioblasto y plaquetas.

C) Plaquetas, megacariocito, megacarioblasto y promegacariocito.

D) Megacarioblasto, mieloblasto, megacariocito y plaquetas.

74. Si realizamos un hemograma a una paciente con trombocitemia esencial (TE) encontraremos recuentos plaquetarios de:

A) 750.000-1.000.000/mm³

B) 750-1.000/mm³

C) 150-4.000/mm³

D) No es una prueba estimable en la TE.

75. ¿Cuál es la causa más frecuente de neutrofilia?

A) Infecciones

B) Tumores

C) Hemorragias

D) Alergias

76. Los leucocitos se subdividen en:

A) Granulocitos, linfocitos y monocitos

B) Neutrófilos, eosinófilos y basófilos

C) Eosinófilos, linfocitos y basófilos

D) Granulocitos, linfocitos y eosinófilos

77. En ocasiones, el anticoagulante EDTA tripotásico plantea un inconveniente en algunos pacientes produciéndoles una pseudotrombopenia,



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

denominado fenómeno EDTA. ¿Qué NO se debe hacer ante la sospecha de éste para descartarlo?

- A) Determinación de plaquetas en el tubo de citrato, si lo tenemos en el laboratorio.
- B) Al resultado de plaquetas obtenido del autoanalizador, le sumaremos un 10%.
- C) Revisión microscópica, con recuento manual de plaquetas.
- D) Centrifugar la muestra del tubo de citrato para la determinación de las plaquetas.**

78. El gradiente de Ficoll-Paque es usado habitualmente para:

- A) Purificación de apoproteínas.
- B) Aislamiento de parásitos intestinales.
- C) Aislamiento de linfocitos.**
- D) Cuantificación de proteínas en la orina.

79. En una extensión de sangre periférica humana, al microscopio óptico, no observaremos nunca:

- A) Eosinófilos, característicos de procesos alérgicos con granulaciones muy refringentes en el citoplasma, que se tiñen con colorantes ácidos.
- B) Reticulocitos con finos filamentos y gránulos que constituyen la más gránulo-filamentosa ortocromática.
- C) Agregados de coilocitos, esféricos con núcleo pequeño, que se tiñen con colorantes básicos.**
- D) Linfocitos peludos o "hairycells", de leucemia de células vellosas (HCL), considerada subtipo de leucemia linfocítica crónica (LLC).

80. Indicar cuál de las siguientes líneas de maduración es cierta, considerando la forma más inmadura la situada más a la izquierda:

- A) Monoblasto - Monoblasto basófilo - Monocito basófilo.
- B) Mielocito basófilo -- Metamielocito basófilo- Basófilo en banda.**
- C) Megacarioblasto - Megacariocito.
- D) Mieloblasto - Linfocito.

81. Una de las siguientes patologías no provoca eosinofilia. Indique cuál:

- A) Parasitosis.
- B) Aplasia medular.**
- C) Alergia.
- D) Síndromes proliferativos.

82. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio suelen aparecer disminuidos en la enfermedad de Hodgkin?:

- A) VSG
- B) Proteína C reactiva.
- C) Albúmina.**
- D) Inmunoglobulinas.

83. ¿Qué podemos decir de un niño de 2 años que tiene un recuento de leucocitos de 10.000/mm³ y un recuento diferencial de 30% neutrófilos, 60% linfocitos, 7% monocitos, 2% eosinófilos y 1% basófilos?:

- A) Existe leucocitosis.
- B) Existe linfocitosis.
- C) Son valores normales.**
- D) Existe eosinofilia.

84. En las plaquetas podemos observar principalmente tres tipos de gránulos en la zona central de su citoplasma. Los gránulos densos son:

- A) Gránulos que presentan aminas. ADP y calcio.**
- B) Gránulos específicos de las plaquetas que contienen factores plaquetarios.
- C) Gránulos que presentan grandes cantidades de hidrolasas ácidas.
- D) Gránulos numerosos que no presentan función secretora.

85. Las manchas de Grumpech se ven en los frotis sanguíneos de pacientes con:

- A) Leucemia linfocítica aguda.
- B) Alfatalasemia.
- C) Leucemia linfocítica crónica.**
- D) Leucemia mielocítica crónica.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

86. En sangre periférica normal, las células de mayor tamaño corresponden a:

- A) Hematíes.
- B) Monocitos.**
- C) Eosinófilos.
- D) Basófilos.

87. Al procesar la muestra en un contador automático, el técnico observa una pancitopenia. ¿Cuál de las opciones te parece la más inmediata?:

- A) Realizar frotis de sangre periférica.
- B) No tener en cuenta las alarmas en los distintos parámetros.
- C) Observar macroscópicamente la muestra y descartar la presencia de coágulos.**
- D) Solicitar reticulocitos.

88. Una parte importante de las plaquetas permanece almacenada en:

- A) Médula ósea
- B) Pulmones
- C) Bazo**
- D) Hígado

89. El Síndrome de Bernard- Soulier podemos definirlo como:

- A) Déficit del complejo GPIIb-IIIa de la membrana plaquetaria, sin alteraciones en la morfología plaquetar
- B) Trombopenia de origen periférico
- C) Trombocitosis sin alteraciones funcionales de las plaquetas
- D) Déficit del complejo GPIIb- IX de la membrana plaquetaria, con plaquetas gigantes, con frecuencia trombopénicas**

90. En la purpura idiopática trombocitopénica, señala la correcta:

- A) Es una enfermedad autoinmune.
- B) Es un trastorno hemorrágico.

C) Cursa con trombopenia y aumento moderado de linfocitos.

D) Todas correctas.

91. La parte de las plaquetas encargada de la adhesión se denomina:

- A) Membrana celular
- B) Glucocáliz**
- C) Hialoplasma
- D) Ninguna de las anteriores

92. Las granulaciones citoplasmáticas de las plaquetas son:

- A) Gránulos densos, alfa y beta.
- B) Gránulos densos, alfa y lisosomas.**
- C) Gránulos alfa, beta y gamma.
- D) Gránulos alfa y beta.

93. Las inclusiones citoplasmáticas, en forma de varillas, formadas por la fusión de la granulación azurófila en los blastos se denominan:

- A) Cuerpos de Döhle.
- B) Sombras de Gumprecht.
- C) Bastones de Auer.**
- D) Cromatina de Barr.

94. ¿En cuál de los siguientes procesos patológicos sería esperable encontrar una leucopenia?

- A) Artritis reumatoide.
- B) Tratamiento con quimioterápicos.**
- C) Leucemia aguda.
- D) Síndrome mieloproliferativo crónico.

95. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa, respecto a los linfocitos activados?

- A) La relación núcleo-citoplasma está aumentada.**
- B) El citoplasma suele ser hiperbasófilo.
- C) Pueden encontrarse en cuadros de mononucleosis infecciosa.
- D) Aparecen de manera fisiológica en niños recién nacidos.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

96. Se considera trombocitosis cuando la cifra de plaquetas es:

- A) $<450 \times 10^9/L$.
- B) $>250 \times 10^9/L$.
- C) $>450 \times 10^9/L$.
- D) $>150 \times 10^9/L$.

97. Una de las siguientes afirmaciones es falsa, respecto a las plaquetas:

- A) Se originan a partir de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos.
- B) Tienen un tamaño entre 1-3 μm .
- C) Su función es la hemostasia primaria.
- D) Tienen un núcleo excéntrico.

98. ¿Cuál de las siguientes puede ser causa de trombocitopenia ficticia?

- A) La utilización de tubos con EDTA para la realización del hemograma.
- B) La utilización de tubos con citrato sódico para la realización del hemograma.
- C) El abuso de alcohol.
- D) El déficit de trombopoyetina.

99. Señale cuál, de los siguientes elementos formes de no es una célula:

- A) Neutrófilos.
- B) Hematíes.
- C) Macrófagos.
- D) Plaquetas.

100. ¿En cuál, de los siguientes procesos patológicos, esperaríamos encontrar una eosinofilia?

- A) Enfermedades autoinmunes.
- B) Parasitosis.
- C) Viriasis.
- D) Leucemia linfática crónica.

101. ¿El uso de qué anticoagulante en los tubos de muestra puede producir una frecuencia mayor de pseudotrombopenias en los analizadores de hematología?:

- A) Citrato.
- B) EDTA.
- C) Oxalato.
- D) Heparina

102. La Leucemia mieloide crónica:

- A) Afecta especialmente a pacientes jóvenes (edad mediana de aparición de 27 años).
- B) Es una enfermedad monofásica: fase aguda o crisis blástica (CB)
- C) El índice de la fosfatasa alcalina granulocitaria (FAG) está aumentado en el 95% de los casos.
- D) El estudio citogenético de MO pone de manifiesto la existencia de la t (9;22) (q34;q11) en el 95% de los casos

103. En la leucemia linfóide crónica, sobre los linfocitos es ERRÓNEO que:

- A) Pueden presentar granulaciones en forma de bastones de Auer.
- B) El citoplasma es pequeño.
- C) Debido a su fragilidad pueden romperse al extender el frotis y formar sombras de Gumprecht.
- D) La cromatina es madura y condensada

104. No es una alteración cuantitativa de los leucocitos:

- A) Linfopenia.
- B) Linfocitos con proyecciones.
- C) Monocitosis.
- D) Basofilia.

105. Para poder diagnosticar una leucemia, sería necesario:

- A) Una muestra de esputo.
- B) Una muestra de médula ósea.
- C) Una muestra de orina.
- D) Una muestra de heces.

106. Los eosinófilos:

- A) Constituyen el 2-5% de los leucocitos en sangre periférica.
- B) Constituyen menos del 0,2% de los leucocitos en sangre periférica.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:    **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

- C) Constituyen el 90% de los polimorfonucleares.
D) Proviene de los ganglios linfáticos.

107. En una fórmula leucocitaria, se dice que hay una desviación a la izquierda si:

- A) Hay un aumento de porcentaje de formas juveniles de los neutrófilos en sangre periférica.
B) Hay un aumento de porcentaje de segmentados en sangre periférica.
C) Si hay una disminución de monocitos en sangre periférica.
D) Todas son correctas.

108. ¿Qué son los pleocariocitos?

- A) Son plaquetas inmaduras
B) Son neutrófilos hipersegmentados con cuatro lóbulos en su núcleo
C) Son neutrófilos hipersegmentados mayores con más de cinco lóbulos en su núcleo
D) Son neutrófilos en fase inmadura

109. ¿Cuál de las tinciones siguientes se utiliza para diferenciar los blastos de origen mieloide o linfoide?

- A) Tinción PAS
B) Tinción de los
C) Tinción de la peroxidasa
D) Tinción de May-Grünwald-Giemsa

110. En el mieloma múltiple se produce una proliferación clonal de:

- A) Neutrófilos inmaduros
B) Linfocitos t
C) Células plasmáticas
D) Mielocitos

111. Señala la respuesta incorrecta:

- A) Las células mononucleadas corresponden a linfocitos y monocitos
B) El mielocito pertenece a la serie granulocítica
C) El basófilo pertenece a la serie linfoide
D) Los leucocitos se dividen en polimorfonucleares y mononucleares

112. ¿Para qué se utiliza la técnica de plaquetas en citrato?

- A) Para determinar rápidamente la coagulación del paciente
B) Para ver si las plaquetas del paciente son grandes
C) Para evitar que las plaquetas se agreguen en presencia del anticoagulante EDTA, en pacientes EDTA-dependientes
D) Para el diagnóstico de la trombocitemia esencial

113. Es un tipo de leucemia crónica:

- A) Leucemia perniciosa
B) Leucemia linfocítica
C) Leucemia macrocítica
D) Leucemia microcítica

114. La enfermedad de Hodgkin es el linfoma más frecuente, ¿cuál es la célula cuya presencia va a diagnosticar dicha enfermedad?

- A) Sombras de Gumprecht.
B) Reed-Sternberg.
C) Mieloblastos diferenciales.
D) Ninguna es correcta

115. ¿En cuál de las siguientes situaciones NO puede observarse una linfocitosis?:

- A) Leucemia linfocítica aguda.
B) Leucemia linfocítica crónica.
C) Infecciones bacterianas.
D) Linfoma de Hodgkin.

116. ¿A partir de que valores de plaquetas existe elevado riesgo de hemorragia?

- A) De 150.000-300.000 / μ l
B) De 100.000-150.000 / μ l
C) De 20.000-50.000 / μ l
D) De 100.000-50.000 / μ l

117. Cuando el antígeno estimula a los linfocitos B estos se transforman en células blásticas que constituyen el centro germinal, ¿qué tipo de células hay?

- A) CD20, CD79a y CD10.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

- B) CD20a y CD79a.
- C) CD20a, CD79a, CD10 y CD120a.
- D) CD20a, CD79a, CD10 y CD12a.

118. ¿Qué tipo de granulocitos suelen estar elevados en manifestaciones alérgicas?

- A) Neutrófilos.
- B) Eosinófilos.**
- C) Basófilos.
- D) Monocitos.

119. ¿Con qué técnica se monitoriza la LMC?

- A) BCR-ABL.**
- B) Pfa-100.
- C) Elisa.
- D) No se monitoriza, sólo se realiza el diagnóstico

120. La PTI o Enfermedad de Werlhof es una trombopenia inmune idiopática producida por:

- A) La adhesión de autoanticuerpos a la membrana de las plaquetas.**
- B) Digestión del citoplasma por fármacos.
- C) A y B son ciertas.
- D) Ninguna es cierta.

121. Hombre de 60 años con el siguiente hemograma: leucocitos 10.000/mL con desviación izquierda, Hb 11 g/dL y plaquetas 1.870.000 / uL con importante anisotrombia. Moderada esplenomegalia en el examen físico. En el estudio molecular se detecta reordenamiento del gen BCR/ABL y no se detecta mutación en el gen JAK2 ¿Cuál es diagnóstico correcto?

- A) Trombocitemia esencial.
- B) Leucemia mieloide crónica.**
- C) Mielofibrosis en fase prefibrótica.
- D) Leucemia aguda megacarioblástica.

122. ¿Qué células sanguíneas circulantes se diferencian hacia macrófagos en los tejidos?

- A) Neutrófilos.
- B) Monocitos.**
- C) Macrófagos inmaduros.

D) Células mieloides progenitoras circulantes.

123. Indique la respuesta FALSA sobre las plaquetas:

- A) Se forman por fragmentación del citoplasma del megacariocito.
- B) Son los elementos formes de la sangre de menor tamaño.
- C) Carecen de núcleo y de granulación.**
- D) Tienen una gran capacidad de agregación

124. ¿Cuál de las siguientes células inmunes no suele circular en sangre?

- A) Monocito.
- B) Eosinófilo.
- C) Macrófago.**
- D) Neutrófilo.

125. ¿Qué técnica es la más habitual para identificar las proteínas presentes en el mieloma?

- A) Inmunoaglutinación
- B) Inmunoprecipitación
- C) Inmunofijación**
- D) Inmunodifusión

126. La Púrpura Trombocitopénica Idiopática (PTI), de entre los siguientes, ¿por qué otro nombre es conocida?

- A) Síndrome hemolítico urémico
- B) Trombocitopenia esencial
- C) Inmunotrombopenia**
- D) Púrpura trombótica trombocitopénica

127. La leucemia promielocítica se caracteriza frecuentemente por:

- A) Blastos indiferenciados y ocasionales bastones de Auer
- B) Promielocitos hipergranulares con abundantes bastones de Auer**
- C) Blastos con diferenciación monocítica
- D) Promielocitos hipergranulares y ausencia de bastones de Auer



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

128. En la actualidad, la técnica de elección para la cuantificación de las distintas subpoblaciones linfocitarias de sangre periférica es:

- A) El hemograma
- B) La inmunohistoquímica
- C) La inmunocitoquímica
- D) La citometría de flujo

129. ¿Qué tinción es útil en el diagnóstico diferencial de los síndromes mieloproliferativos?

- A) Fosfatasa ácida leucocitaria
- B) Fosfatasa alcalina leucocitaria
- C) Tinción del ácido periódico de Schiff
- D) Tinción de esterasa ácida

130. Señale el principal papel inmunológico de la médula ósea:

- A) Síntesis de médula
- B) Síntesis de hueso
- C) Generación de precursores hematopoyéticos
- D) Generación de timocitos

131. Una cifra de linfocitos equivalente a 500 células/microlitro se define como una:

- A) Linfopenia
- B) Linfocitosis
- C) Leucopenia
- D) Leucocitosis

132. Señale la respuesta correcta, en un linfoma Hodgkin podemos encontrar células:

- A) Reed-Stenberg.
- B) Epstein-Barr.
- C) Ninguna célula es típica de esta enfermedad
- D) Bence-Jones.

133. ¿Qué situaciones patológicas pueden causar trombopenia?

- A) Infecciones agudas.
- B) Neoplasia.
- C) Hemorragias.
- D) Todas son correctas.

134. ¿Cuál de las siguientes no es una trombocitopatía adquirida?

- A) Anemia aplásica.
- B) Defectos de agregación plaquetaria.
- C) CID.
- D) Leucemia aguda.

135. El lugar dónde maduran y se diferencian los precursores de los linfocitos B en los mamíferos es

- A) Timo.
- B) Médula ósea.
- C) Bazo.
- D) Riñón.

136. En el mieloma múltiple, de entre los siguientes, ¿a cuál se hace responsable del síndrome de Raynaud?

- A) La hiperviscosidad sanguínea
- B) Las crioglobulinas
- C) La proteína de Bence-Jones
- D) El aumento de la VSG

Comentario. Síndrome de Raynaud es un trastorno que se caracteriza por una disminución de la circulación sanguínea en los dedos de las manos y de los pies, que produce dolor y cambios de coloración en dichas localizaciones. Los factores que lo desencadenan son los cambios de temperatura (generalmente el frío) y las situaciones de estrés y emociones.

137. ¿Cuál de las siguientes no es una célula del sistema inmune?

- A) Linfocitos.
- B) Monocitos.
- C) Hematíes.
- D) Neutrófilos.

138. Las sombras de Gumprecht son

- A) Blastos que aparecen en la leucemia mieloide aguda.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

B) Linfocitos pequeños frágiles de la leucemia linfoide crónica.

- C) Linfocitos inmaduros del linfoma de Hodgkin.
D) Linfocitos atípicos en las displasias.

139. La célula de Reed- Sternberg es típica del:

A) Linfoma de Hodgkin.

- B) Linfoma no Hodgkin.
C) Mieloma múltiple.
D) Leucemia linfoide aguda.

140. En las leucemias el criterio de clasificación FAB se basa en

- A) El origen.
B) El fenotipo.
C) La morfología.
D) Los antígenos de superficie.

141. Señale la afirmación falsa

- A) La leucopenia es la disminución en el número de glóbulos blancos (leucocitos) a menos de 4000 células por microlitro de sangre.
B) La leucocitosis es un aumento en el número de glóbulos blancos (leucocitos) de más de 11.000 células por microlitro de sangre.
C) La neutropenia es un número anormalmente bajo de neutrófilos.
D) La linfocitopenia consiste en un número anormalmente alto de linfocitos.

142. Entre las causas de neutropenia se encuentran las siguientes, excepto

- A) Mieloptisis.
B) Anemia aplásica.
C) Síndrome de Chediak-Higashi.
D) Todas las anteriores pueden ser causas de neutropenia.

143. En el frotis de sangre periférica podemos encontrar las siguientes alteraciones morfológicas. Señale la respuesta falsa

A) Neutrófilos hipersegmentados: son células que muestran más de 5 lobulaciones en el núcleo y se asocian con anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, con los síndromes mielodisplásicos y secundario al tratamiento con metotrexate.

B) Células de Turk: son células de aspecto plasmocitoide y se observan en enfermedades virales, tuberculosis, linfomas, mieloma múltiple y carcinoma.

C) Linfocitos atípicos: son células mononucleares con citoplasma vacuolado, núcleo lobulado y con nucléolo y cromatina condensada. Son frecuentes en mononucleosis infecciosa, hepatitis viral, tos ferina, crup y posvacunación.

D) Cuerpos de Aüer: Presencia de granulación azurófila gruesa en los núcleos de los neutrófilos de pacientes con mucopolisacaridosis.

144. Con respecto al estudio de inmunofenotipo señale la respuesta correcta:

A) La citometría de flujo constituye una técnica avanzada, automatizada, objetiva y altamente sensible, muy útil para el estudio del inmunofenotipo.

B) Para realizar un análisis inmunofenotípico por citometría de flujo, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos metodológicos: tipo de muestra, cantidad, conservación y transporte, uso de anticoagulantes, empleo de anticuerpos monoclonales y fluorocromos, lisado de hematíes, fijación celular, calibración y compensación de los citómetros, previo a la interpretación de los resultados.

C) Para la determinación de las distintas subpoblaciones celulares, se utiliza la inmunofluorescencia directa en la que los anticuerpos llevan directamente unido un fluorocromo identificativo para moléculas de superficie leucocitaria.

D) Todas las respuestas anteriores son correctas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

145. Los tipos de leucemia van a estar en función de

- A) El tipo de célula afectada y la rapidez de instauración.
- B) El tipo de célula afectada y el recuento de la misma.
- C) El tipo de hematíes afectado y su coloración.
- D) Ninguna de las anteriores es cierta.

146. La mononucleosis infecciosa se asocia a

- A) La bacteria Salmonella epidermidis.
- B) El virus de Epstein Barr.
- C) El virus del Herpes zoster.
- D) Se desconoce la asociación.

147. La línea de maduración normal de las plaquetas es

- A) Megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito y plaquetas.
- B) Megacariocito, promegacarioblasto, megacarioblasto y plaquetas.
- C) Plaquetas, megacariocito, promegacariocito y megacarioblasto.
- D) Ninguna es cierta.

148. ¿Cuál de las siguientes no es una función plaquetaria?

- A) Control de homeostasia en vasos intactos.
- B) Control de hemorragias en vasos heridos.
- C) Activación de la hemostasia secundaria.
- D) Todas son funciones plaquetarias.

149. Una trombocitopenia es un recuento plaquetario

- A) Superior a 400.000/mm³.
- B) Inferior a 400.000/mm³.
- C) Superior a 150.000/mm³.
- D) Inferior a 130.000/mm³.

150. ¿Cuál de los siguientes no es un error típico en el recuento plaquetario?

- A) Satelismo.
- B) Agregación plaquetaria.
- C) Superposición plaquetaria.
- D) Todos son errores normales en el recuento.

151. ¿Cuál de las siguientes patologías no se incluye en el grupo de neoplasias mieloproliferativas?

- A) Policitemia vera.
- B) Mielofibrosis primaria.
- C) Linfoma de Burkitt.
- D) Trombocitemia esencial.

152. La leucemia mieloide crónica (LMC):

- A) Cursa con aumento principalmente de células granulocíticas.
- B) Cursa con aumento principalmente de linfocitos B.
- C) Cursa con aumento principalmente de linfocitos T.
- D) Cursa con aumento principalmente de eritrocitos.

153. ¿Cuál de las siguientes unidades formadoras de colonias corresponde a la célula progenitora común para los neutrófilos y monocitos?

- A) UFC-E.
- B) UFC-G.
- C) UFC-GM.
- D) UFC-M.

154. ¿Cuál es el marcador principal que expresa la célula Stem hematopoyética?

- A) CD34.
- B) CD36.
- C) CD8 y CD4.
- D) CD3 y CD8.

155. El mieloma múltiple cursa con proliferación de:

- A) Plaquetas.
- B) Células plasmáticas.
- C) Hematíes.
- D) Neutrófilos.

156. La Policitemia vera es una forma de...:

- A) Poliglobulia primaria congénita.
- B) Poliglobulia primaria adquirida.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

- C) Poliglobulia secundaria congénita.
- D) Poliglobulia secundaria adquirida.

157. Las manchas de Gumprecht se observan en:

- A) LMC (leucemia mieloide crónica).
- B) LLC (leucemia linfática crónica).**
- C) Mieloma múltiple.
- D) Linfoma.

158. El recuento leucocitario se puede realizar mediante:

- A) Medios ópticos.
- B) Autoclave.
- C) Medios electrónicos.
- D) A y C son correctas.**

159. Indique qué células son predominantes en un recuento diferencial de un adulto sano:

- A) Linfocitos.
- B) Eosinófilos.
- C) Monocitos.
- D) Neutrófilos.**

160. La técnica para la preparación de extensiones de médula ósea es:

- A) Técnica por aplastamiento.
- B) Técnica del portaobjetos en cuña.
- C) Técnica del portaobjetos extensor.
- D) A y B son ciertas.**

161. Cuando la neutrofilia va acompañada de la presencia de formas jóvenes de neutrófilos se denomina:

- A) Neutrofilia incipiente.
- B) Neutrofilia con desviación a la izquierda.**
- C) Neutrofilia leve.
- D) Neutrofilia activa.

162. Es cierto que:

- A) Los linfocitos B y T se originan en la médula ósea a partir de un precursor común.**

B) Los linfocitos B y T se originan en la médula ósea a partir distintos precursores.

C) Los linfocitos B y T se originan en el timo a partir de un precursor común.

D) Los linfocitos B y T se originan en el timo a partir distintos precursores.

163. La eritrocitosis se define como el aumento de la masa eritrocitaria. Para el diagnóstico de la policitemia vera (PV), se debe realizar el estudio de la mutación del gen Jak 2 presente aproximadamente en el:

- A) 70% de los casos de PV.
- B) 85% de los casos de PV.
- C) 87% de los casos de PV.
- D) 97% de los casos de PV.**

164. La presencia de vacuolas citoplasmáticas en los neutrófilos suele indicar:

- A) Neoplasias.
- B) Infecciones.**
- C) Alteración cromosómica.
- D) Exposición a radiación ionizante.

165. ¿Qué célula se transforma en célula plasmática cuando entra en contacto con el antígeno?:

- A) Linfocito T.
- B) Monocito.
- C) Linfocito B.**
- D) Granulocito.

166. Con respecto a la sangre ¿Cuál es la respuesta correcta?:

- A) El plasma no contribuye a la regulación del pH.
- B) Los monocitos tienen una función esencialmente fagocítica.**
- C) Los leucocitos son el componente celular más abundante.
- D) El plasma constituye el 90% del volumen total de la sangre.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

167. ¿Cuál de los siguientes leucocitos desempeña un papel importante en las infecciones parasitarias por helmintos?:

- A) Monocitos.
- B) Basófilos.
- C) Neutrófilos.
- D) Eosinófilos.**

168. Con respecto al síndrome de Sézary, señale la respuesta correcta:

- A) Son característicos los leucocitos mononucleares con núcleo cerebriforme.**
- B) Son típicos los linfocitos con el núcleo mellado.
- C) Son característicos los neutrófilos con dos lóbulos.
- D) Podemos observar neutrófilos grandes y con núcleos hipersegmentados.

169. ¿Cuál de las siguientes leucemias es la más frecuente en la niñez?:

- A) Leucemia mieloide aguda (LMA).
- B) Leucemia mieloide crónica (LMC).
- C) Leucemia linfoide aguda (LLA).**
- D) Leucemia linfoide crónica (LLC).

170. Con respecto a la leucemia mieloide crónica señale la respuesta correcta:

- A) Se caracteriza por la excesiva producción de granulocitos.
- B) Las radiaciones ionizantes no influyen en la génesis.
- C) Es característico el cromosoma de Filadelfia.
- D) Las respuestas a y c son correctas.**

171. La adhesión y agregación plaquetaria, tanto "in vivo" como "in vitro", es una cuestión con la que debemos estar familiarizados en el laboratorio. Sabemos entonces que es FALSO que:

- A) La pseudotrombocitopenia inducida por EDTA es un fenómeno que se presenta "in vitro" y numerosos estudios evidencian que está mediado por anticuerpos anti - plaquetarios dirigidos contra

el complejo glucoprotéico IIb/ IIIa de la membrana plaquetaria.

B) En la trombastenia de Glanzmann hay un déficit en la cantidad de glucoproteínas IIb / IIIa de la membrana plaquetaria.

C) Una causa de falsa trombocitopenia relacionada con el EDTA es la que acontece en los casos de satelitismo plaquetario con presencia de plaquetas alrededor de polimorfonucleares neutrófilos.

D) El diagnóstico del síndrome de Bernard - Soulier puede realizarse de forma rápida en base a la ausencia de expresión en membrana plaquetar de CD41 (gplIb / IIIa).

172. Tras examinar los casos más relevantes de trombocitopenia en el centro hospitalario donde trabajo, sé que es FALSO que:

A) La trombocitopenia inmunitaria se conocía anteriormente con el nombre de púrpura trombocitopénica idiopática y en niños se desarrolla con frecuencia tras una infección viral, caso en el que suele remitir espontáneamente.

B) La trombocitopenia inmunitaria puede ser de carácter hereditario, en este caso se relaciona con un déficit de la enzima ADAMTS13.

C) La púrpura trombótica trombocitopénica se trata en muchas ocasiones con plasmaféresis.

D) La púrpura trombótica trombocitopénica sin tratamiento con frecuencia es letal.

173. Al observar al microscopio óptico un frotis sanguíneo sin alteraciones y teñido con la tinción de Wright, puedo identificar con claridad un basófilo porque:

A) El núcleo posee una cromatina densa y suele tener de 2 a 3 lóbulos, el citoplasma es basófilo y está lleno de gránulos esféricos de color rojo violáceo de tamaño uniforme distribuidos de forma regular.

B) El núcleo posee una cromatina densa y suele ser bilobular pero su conformación real muchas veces se oculta por la presencia de gránulos



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

suprayacentes. El citoplasma es acidófilo y pocas veces se observa, ya que suele estar oculto por los gránulos que son grandes de color negro morado y de distribución irregular.

C) El núcleo posee una cromatina densa y suele tener de 2 a 5 lóbulos, el citoplasma es basófilo y contiene gránulos neutros y azurófilos, pequeños, muy abundantes y distribuidos de forma regular.

D) El núcleo posee una cromatina densa y suele tener de 2 a 3 lóbulos pero su conformación real muchas veces se oculta por la presencia de gránulos suprayacentes. El citoplasma es basófilo y está lleno de gránulos grandes de tamaño uniforme de color negro morado y de distribución irregular.

174. Señale donde encontramos el reservorio principal de calcio de las plaquetas:

- A) Sistema tubular denso.
- B) Gránulos alfa.
- C) Capa exterior o glucocálix.
- D) Sistema canicular abierto.

175. Un paciente de 70 años ha sido diagnosticado recientemente de mieloma múltiple. Se le han realizado diversas pruebas de laboratorio y en todas ellas se han obtenido resultados esperados para esta patología. Cuál de los siguientes sería uno de ellos:

- A) Plasmocitosis en sangre periférica mayor del 30%.
- B) Hipocalcemia muy marcada acompañada de lesiones óseas.
- C) Expresión de CD56 en sus células plasmáticas.
- D) Ninguna es correcta.

176. En el hialoplasma de las plaquetas hay microfilamentos ricos en proteínas contráctiles, ¿cuál de las siguientes NO es una de ellas?:

- A) Miosina
- B) Troponina
- C) Actina
- D) Fibronectina

Comentario. Juego con el lenguaje. Te hablan primero de las plaquetas para que pienses sobre ellas, pero luego te preguntan qué indiques cual no es contráctil. La fibronectina tiene una función más bien de adhesión y de facilitación de la agregación plaquetaria

177. Señale la afirmación correcta en relación a la granulación de las plaquetas:

- A) Los gránulos alfa son los más escasos pero los más específicos, contienen factor plaquetario 4, factor Von Willebrand, fibrinógeno y otras proteínas.
- B) Los gránulos densos son los más abundantes y contienen serotonina, lisosomas, ADP y ATP.
- C) Los gránulos alfa son los más abundantes y contienen gran diversidad de proteínas específicas y no específicas.
- D) Los gránulos densos son los más escasos y contienen serotonina, lisosomas, ADP y ATP.

178. Señale la afirmación correcta en relación a la clasificación de leucemias:

- A) La clasificación Franco-América-Británica creada en 1976 divide a las leucemias mieloides crónicas en 8 subtipos, de M0 a M7, y a las linfoides en 3.
- B) La clasificación FAB se basa en la citogenia, citometría de flujo, inmunohistoquímica, el análisis de la historia clínica, la influencia de terapias citotóxicas y la comorbilidad con otros desordenes hematológicos lo cual permite obtener una gran eficacia clínica y terapéutica.
- C) En la clasificación de la Organización Mundial de la Salud se aumentó a un 20% el porcentaje de blastocitos leucémicos en médula ósea exigido para el diagnóstico de la LMA en contraste al 10% que venía exigiendo la FAB.
- D) En las M3 de la clasificación FAB el promielocito predominante atípico es de tamaño mediano-grande y núcleo de perfil irregular con una incisura amplia (signo del hachazo) e inclusiones



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

citoplasmáticas. Son muy positivos para la mieloperoxidasa y Negro Sudán B.

179. ¿Cuál es la primera célula de estirpe granulocítica, que deriva de la CFU-G, que es reconocible morfológicamente?

- A) Linfoblasto.
- B) Mieloblasto.**
- C) Eritroblasto.
- D) Monoblasto.

180. ¿Qué es la anisocitosis plaquetaria?

- A) Un aumento en el número de plaquetas.
- B) Una disminución en el número de plaquetas.
- C) Presencia, en sangre periférica, de plaquetas gigantes.
- D) Presencia, en sangre periférica, de plaquetas de distintos tamaños.**

181. ¿En qué estructura de las plaquetas se encuentra la reserva principal del calcio empleado en la contracción de algunos componentes de las plaquetas?

- A) En la membrana.
- B) En los lisosomas.
- C) En las mitocondrias.
- D) En el sistema tubular denso.**

182. El Factor de von Willebrand:

- A) Se encuentra en los gránulos alfa de los trombocitos.**
- B) Interviene en la activación de la vía extrínseca de la coagulación.
- C) Se denomina también f3p (Factor 3 plaquetario).
- D) Es un factor inhibidor de la coagulación.

183. ¿Cuáles son los leucocitos MENOS abundantes en la sangre periférica?

- A) Basófilos.**
- B) Linfocitos.
- C) Monocitos.
- D) Eosinófilos.

184. El hiató leucémico es característico de:

- A) LMA (Leucemia mieloide aguda).**
- B) LMC (Leucemia mieloide crónica).
- C) LLC (Leucemia linfóide crónica).
- D) Mononucleosis infecciosa.

185. La célula de Sternberg-Reed:

- A) Es característica del linfoma de Hodgkin.**
- B) Es característica de los linfomas no Hodgkinianos.
- C) Es característica del mieloma múltiple.
- D) Es característica de la macroglobulinemia de Waldenström.

186. Los eosinófilos:

- A) Son muy abundantes en la sangre, entre 1.000-5.000/mm³.
- B) Ejercen una acción contra los parásitos del tipo de los helmintos.
- C) Tienen una acción fagocitaria muy inferior a los neutrófilos.
- D) Las opciones B) y C) son correctas.**

187. ¿Cuál es la secuencia normal en el proceso de trombopoyesis?

- A) Promegacariocito, megacarioblasto, megacariocito y trombocito.
- B) Megacarioblasto, promegacariocito, megacariocito y plaqueta.**
- C) Megacarioblasto, trombocito, promegacariocito y plaqueta.
- D) Megacarioblasto, megacariocito, promegacariocito y plaqueta.

188. Respecto a las alteraciones del número de plaquetas, se dice que una trombocitopenia, trombopenia o plaquetopenia puede deberse a la siguiente causa:

- A) Esplenectomía.
- B) Enfermedad de Crohn.
- C) Colitis ulcerosa.
- D) Déficit de ácido fólico o de vitamina B12.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

189. Entre las trombopatías congénitas se encuentran:

- A) Púrpura Trombocítica Trombocitopénica (PTT).
- B) Síndrome de Bernard-Soulier.
- C) Trombastenia de Glanzmann.

D) B) y C) son correctas.

190. Según la clasificación de las leucemias, señale la que cursa con una concentración de leucocitos en sangre periférica que puede ser alta, normal o baja:

- A) Leucemia mieloide crónica (LMC).
- B) Leucemia linfóide crónica (LLC).

C) Leucemia linfóide aguda (LLA).

D) En ninguna leucemia, ya que siempre hay una concentración muy elevada de leucocitos.

191. Atendiendo a la clasificación de los leucocitos, señale la respuesta correcta.

- A) Según su origen, los leucocitos se clasifican en polimorfonucleares (PMN) y leucocitos mieloides.
- B) Según su función, los leucocitos se clasifican en fagocitos y granulocitos.
- C) Según la presencia o la ausencia en su citoplasma de granulaciones visibles con el microscopio óptico, los leucocitos se clasifican en agranulocitos e inmunocitos.

D) Según la forma de su núcleo, los leucocitos se clasifican en polimorfonucleares (PMN) y mononucleares.

192. ¿Cuál es la secuencia completa y correcta en la formación de los leucocitos mieloides?

A) Metamielocito – promielocito – mielocito neutrófilo – neutrófilo en cayado – neutrófilo segmentado.

B) Mieloblasto – promielocito – mielocito neutrófilo – metamielocito – neutrófilo en cayado – neutrófilo segmentado.

C) Mieloblasto – mielocito neutrófilo – metamielocito – neutrófilo en cayado – neutrófilo segmentado.

D) Promielocito – mieloblasto – mielocito neutrófilo – metamielocito – neutrófilo en cayado – neutrófilo segmentado.

193. Señale la respuesta correcta. Se habla de leucocitosis si la cifra de leucocitos es:

A) Entre 11.000 y 25.000 leucocitos/mm³.

B) < 4.000 leucocitos /mm³.

C) > 25.000 leucocitos/mm³ (en reacciones hiperleucocitósicas y reacciones leucemoides).

D) A) y C) son ciertas.

194. En la estructura interna de las plaquetas, en lo referente a la zona de organelas, encontramos... Indicar la respuesta ERRÓNEA.

A) Lisosomas.

B) Masas de glucógeno.

C) Glucocáliz.

D) Mitocondrias.

195. ¿A qué tipo de leucocitos se une fuertemente el colorante azul de toluidina?:

A) Linfocito.

B) Eosinófilo.

C) Basófilos.

196. ¿Cuál de estas enfermedades es un trastorno plaquetario hereditario?:

A) Diabetes tipo I.

B) Púrpura trombocitopénica inmune (PTI).

C) Enfermedad de Von Willebrand.

197. Según el recuento de Schilling, los cayados son:

A) Forma inmadura de neutrófilos.

B) Forma madura de neutrófilos.

C) Forma senil de neutrófilos.

198. El factor de von Willebrand:

A) Inhibe la coagulación.

B) Estabiliza el coágulo de fibrina.

C) Favorece la agregación plaquetaria.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

199. Hablamos de trombocitosis cuando las cifras de plaquetas son:

- A) Inferiores a 50.000 / mm³.
- B) 200.000 – 400.000 / mm³.
- C) Superiores a 500.000 / mm³.

200. En algunas mujeres, los neutrófilos presentan un segmento nuclear terminal denominado:

- A) Cuerpos de Döhle.

B) Palillo de Tambor.

- C) Vacuolas.

Comentario: técnicamente llamados Corpúsculo de Barr:

201. En una fórmula leucocitaria, se dice que hay una desviación a la izquierda si:

- A) Hay un aumento del porcentaje de segmentados en sangre periférica.

- B) Hay una disminución de monocitos en sangre periférica.

C) Hay un aumento del porcentaje de formas jóvenes de los neutrófilos en sangre periférica.

- D) Todas son correctas.

202. En el estudio inmunológico leucocitario, para detectar un patrón anormal de distribución de antígenos se debe utilizar:

A) Citómetro de flujo.

- B) Inmunofluorescencia sobre portaobjetos.

- C) Inmunofluorescencia de células en suspensión.

- D) Reacción en cadena de la polimerasa.

203. ¿Cuál de éstas técnicas citoquímicas se emplea para analizar la presencia de sustancias y enzimas en los leucocitos?

- A) Reacción de PAS (ácido periódico de Schiff).

- B) Reacción de la fosfatasa alcalina.

- C) Reacción de las esterasas.

D) Todas son correctas.

204. La trombastenia de Glanzmann es:

- A) Una trombocitopenia adquirida.

- B) Un defecto adquirido de la adherencia plaquetaria.

- C) Una alteración del metabolismo del ácido araquidónico.

D) Un defecto congénito de la agregación plaquetaria.

205. Los eosinófilos:

A) Constituyen el 1 al 5% de los leucocitos en sangre periférica.

- B) Constituyen menos del 0,2% de los leucocitos en sangre periférica.

- C) Constituyen el 90% de los polimorfonucleares.

- D) Proviene de los ganglios linfáticos.

206. ¿Cuál es el precursor inmediato de las plaquetas?

- A) Promieloblasto.

- B) Promielocito.

C) Megacariocito.

207. ¿A qué se denomina pancitopenia?

- A) Disminución del número de componentes de la serie blanca.

- B) Disminución del número de componentes de la serie roja.

C) Disminución del número de componentes de la serie blanca, serie roja y sistema plaquetario.

208. ¿Cuál de las siguientes células sanguíneas tienen una importante misión en la inmunidad?

- A) Hematíes.

B) Glóbulos blancos.

- C) Plaquetas.

209. ¿Qué porcentaje de los leucocitos de la sangre representan los basófilos?

- A) 3-10%.

B) 0-2 %.

- C) 10-20%.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

210. ¿Cuáles son los leucocitos que pueden verse aumentados en una infección vírica?

- A) Neutrófilos y basófilos.
- B) Neutrófilos y eosinófilos.
- C) Linfocitos y monocitos en algunas virosis.**

211. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los mieloblastos es falsa?

- A) Es una célula redondeada.
- B) Es una célula de 15-20 µm de diámetro.
- C) Su citoplasma escaso es acidófilo.**
- D) Es el elemento celular de la serie granulocítica más inmaduro que puede identificarse por microscopia óptica.

212. Según la forma de su núcleo los leucocitos se clasifican en:

- A) Fagocitos, inmunocitos y basófilos.
- B) Granulocitos y agranulocitos.
- C) Mieloides y linfoides.
- D) Polimorfonucleares y mononucleares.**

213. ¿Qué trastorno genético se hereda de una forma autosómica recesiva y consiste en la ausencia o disminución del receptor plaquetario GPIIb/IIIa.?

- A) Trombastenia de Glanzmann.**
- B) Síndrome de Bernard-Soulier.
- C) Síndrome de plaquetas grises.
- D) Síndrome de Chediak-Higashi.

214. Señale cuál de las siguientes enfermedades cursa con una trombocitosis:

- A) PTI
- B) PTT
- C) Hemofilia A
- D) Trombocitemia esencial**

215. Los leucocitos de mayor tamaño son los:

- A) Neutrófilos segmentados
- B) Monocitos**
- C) Eosinófilos
- D) Neutrófilos cayados

216. ¿En qué células sanguíneas se puede encontrar la alteración de origen genético "anomalía de Pelger Huet"?

- A) Linfocitos B
- B) Neutrófilos**
- C) Linfocitos T
- D) Monocitos

217. Señale con qué tinción podemos realizar un recuento plaquetas al microscopio óptico:

- A) Graham
- B) Violeta Cresil
- C) May-Grünwald Giemsa**
- D) Azul de lactofenol

218. Si analizamos una suspensión celular en un citómetro de flujo y observamos linfocitos CD19+, ¿qué tipo de linfocito será?

- A) Linfocito T citotóxico.
- B) Linfocito T cooperadores.
- C) Linfocitos B.**
- D) Células NK.

219. Señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Las sombras nucleares de Gümprrecht son típicas de leucemia mieloide aguda.**
- B) En la parasitosis podemos encontrar eosinofilia.
- C) El cribado de hemoglobinopatías estructurales puede realizarse por sistemas de cromatografía de alta resolución.
- D) La enzimopatía más frecuente es por déficit de glucosa 6 fosfato.

220. En el caso de que el paciente presentara linfopenia, se podría decir que su causa puede ser debida a:

- A) Inmunodeficiencia.
- B) Linfomas.
- C) SIDA.
- D) Todas son correctas.**



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

221. Cuando en un frotis de sangre periférica se observa el predominio de formas inmaduras en los neutrófilos, se denomina:

- A) Desviación a la derecha.
- B) Desviación a la izquierda.**
- C) Disminución de leucocitos.
- D) Sin desviación.

222. Cuando en un frotis de sangre periférica se observa el predominio de formas inmaduras en los neutrófilos, se denomina:

- A) Desviación a la derecha.
- B) Desviación a la izquierda.**
- C) Disminución de leucocitos.
- D) Sin desviación.

1. Se solicita al paciente una hematimetría, en la cual se observa un recuento de plaquetas extremadamente bajo. El técnico de laboratorio decide hacer un frotis sanguíneo para observarlo al microscopio y ve que hay agregados plaquetarios:

- A) La trombopenia que se observa en el paciente es una falsa trombopenia o pseudotrombopenia.**
- B) Esta agregación de las plaquetas in vitro está mediada por autoanticuerpos que reaccionan frente al citrato sódico que lleva el tubo como anticoagulante.
- C) Los agregados no justifican una cifra baja de plaquetas.

223. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO se corresponde con las características de las plaquetas?

- A) Las plaquetas se originan a partir de la fragmentación del citoplasma de los megacariocitos.
- B) Su función es la hemostasia, es decir, frenar o detener la pérdida de sangre cuando se ha quebrantado la integridad de la pared vascular.

C) En ocasiones, encontramos recuentos altos de plaquetas a causa de un aumento de su tamaño o por agregación.

224. De los siguientes parámetros, señale cuál de ellos corresponde al análisis plaquetario:

- A) ADP.**
- B) ADE.
- C) CHCP.

225. Los bastones de Auer hallados en un frotis sanguíneo son característicos de:

- A) Leucemia mieloide aguda.**
- B) Leucemia linfoide aguda.
- C) Leucemia linfoide crónica.

226. El cromosoma Philadelphia es una anomalía cromosómica en la médula ósea, este trastorno es muy característico de:

- A) Leucemia monocítica aguda.
- B) Leucemia mieloide crónica.**
- C) Leucemia linfática crónica.

227. En la leucemia de células peludas, ¿cuál de estas tinciones es intensamente positiva?:

- A) Tinción de esterasas.
- B) Tinción de la fosfatasa ácida leucocitaria.**
- C) Tinción de la fosfatasa alcalina leucocitaria.
- D) Tinción de la beta-glucuronidasa.

228. Señale la respuesta correcta sobre las trombopenias:

- A) La púrpura idiopática trombocitopénica es un trastorno autoinmune.**
- B) El síndrome hemolítico-urémico afecta generalmente a jóvenes adultos.
- C) La púrpura trombótica trombocitopénica afecta principalmente al riñón.
- D) El atrapamiento de plaquetas por el bazo se denomina enfermedad de Werlhof.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

229. Las Reed-Sternberg son células que encontramos

en:

- A) Tricoleucemia.
- B) Linfoma de Hodgkin.**
- C) Mieloma múltiple.
- D) Leucemia linfocítica crónica.

230. EL estudio de la FAG (fosfatasa alcalina granulocitaria) tiene gran utilidad práctica al permitir efectuar el diagnóstico diferencial entre diversas hemopatías. ¿En cuáles de las siguientes entidades encontramos la FAG disminuida?

- A) Hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN) y mielofibrosis primaria.
- B) Reacciones leucemoides neutrofílicas y HPN.
- C) Mielofibrosis primaria y leucemia mieloide crónica.
- D) HPN y leucemia mieloide crónica.**

231. La deficiencia congénita o disfunción de GPIb-IX-V, está asociada a:

- A) Enfermedad de Von Willebrand.
- B) Hemofilia.
- C) Tromboastenia de Glanzmann.
- D) Síndrome de Bernard-Soulier.**

232. El Mieloma Múltiple es una proliferación neoplásica de:

- A) Linfocitos T.
- B) Mielocitos.
- C) Linfocitos B.
- D) Células plasmáticas.**

233. Hablamos de leucopenia cuando el recuento total de leucocitos está por debajo de:

- A) $6 \times 10^9/L$.
- B) $4 \times 10^9/L$.**
- C) $10 \times 10^9/L$.
- D) $11 \times 10^9/L$.

234. Se considera trombocitosis cuando la cifra del recuento plaquetario es:

- A) $< 450 \times 10^9/L$.
- B) $> 250 \times 10^9/L$.
- C) $> 400 \times 10^9/L$.**
- D) $> 150 \times 10^9/L$.

235. La presencia en sangre de plaquetas en un tamaño mucho menor al normal se conoce como:

- A) Megatrombocitosis.
- B) Anisocitosis.
- C) Trombopenia.
- D) Microtrombocitosis.**

236. ¿En qué células se observan generalmente los bastones de Auer?

- A) Linfoblastos.
- B) Reticulocitos.
- C) Mieloblastos.**
- D) Eosinófilos.

237. ¿Cuál de las siguientes características corresponde al mieloma múltiple?

- A) El cromosoma Philadelphia.
- B) Hipergammaglobulinemia policlonal.
- C) Lesiones osteolíticas.**

238. Son células linfoides:

- A) Neutrófilos, eosinófilos y basófilos.
- B) Neutrófilos, basófilos y linfocitos T.
- C) Linfocitos T, Linfocitos B y Células NK.**

Nota: las células NK y NKT son de tipo linfocitoide

239. ¿Cuál es el tipo de tumor que más se relaciona con las radiaciones ionizantes?

- A) Cáncer de pulmón.
- B) Leucemia.**
- C) Cáncer de piel.
- D) Cáncer gástrico.

240. Se suele observar neutrofilia en:

- A) Meningitis.
- B) Intoxicaciones metabólicas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

C) Hemorragias agudas.

D) En todas las anteriores.

241. En relación con la pseudotrombocitopenia, señale la respuesta correcta:

A) Los autoanalizadores permiten detectar cuando una trombocitopenia es de naturaleza inmune.

B) Un recuento de plaquetas adicional en una muestra de sangre extraída en presencia de otro anticoagulante distinto al EDTA y una revisión del frotis de sangre periférica permiten detectar la mayoría de pseudotrombocitopenias de causa inmune.

C) Entre las pseudotrombocitopenias de mecanismo inmune, las producidas por anticuerpos EDTA dependientes son las menos frecuentes.

D) Los pacientes con pseudotrombocitopenia suelen presentar diátesis hemorrágica

242. Las sombras de Gümprich observadas en sangre periférica son típicas de:

A) Leucemia linfática crónica.

B) Leucemia prolinfocítica.

C) Leucemia de linfocitos grandes granulares.

D) Tricoleucemia

243. La mieloperoxidasa de los granulocitos está localizada en:

A) La membrana.

B) Los gránulos azurófilos.

C) Los gránulos secundarios.

D) Las mitocondrias.

244. Para confirmar una sospecha de pseudotrombocitopenia detectada al utilizar un contador hematológico electrónico debida a agregados plaquetarios se pueden seguir distintas acciones ¿Cuál de las siguientes NO es correcta?:

A) Examen microscópico de frotis sanguíneo de la sangre periférica.

B) Determinación del tiempo de hemorragia.

C) Solicitar una nueva muestra extraída en tubo de citrato sódico.

D) Repetir la extracción del tubo de EDTA.

245. En relación al diagnóstico de la Policitemia Vera (PV), señale la respuesta correcta:

A) Uno de los criterios mayores para el diagnóstico de PV es el aumento en el número de hematíes > 50 % del IRB superior.

B) Es un criterio menor en el diagnóstico de PV una concentración de eritropoyetina (EPO) aumentada.

C) Una concentración de hemoglobina > 16 g/dL en hombre es uno de los criterios mayores para el diagnóstico de PV.

D) La presencia de la mutación en el exón 14 de JAK2 V617F o la mutación en el exón 12 de JAK2 constituye uno de los criterios mayores para el diagnóstico de PV.

246. ¿Cuál de las siguientes células inmaduras de la granulopoyesis carece típicamente de granulaciones en su citoplasma?:

A) Mielocito.

B) Metamielocito.

C) Mieloblasto.

D) Promielocito.

247. En la fórmula de Arneth de clasificación de los leucocitos, una desviación a la izquierda indica:

A) Producción de leucocitos nuevos o la presencia de formas jóvenes más inmaduras.

B) Alto porcentaje en la fórmula leucocitaria de neutrófilos con el núcleo multilobulado.

C) Aumento en la cifra total de glóbulos blancos por encima del valor normal establecido.

D) Ninguna es correcta

248. Las células de Sézary son:

A) Linfocitos con núcleo cerebriforme

B) Neutrófilos con granulación tóxica

C) Monocitos de aspecto reactivo

D) Neutrófilos degranulados

249. ¿Qué células no son de estirpe mieloide?



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

- A) Basófilos
- B) Linfocitos NK**
- C) Eritrocitos
- D) Células dendríticas

250. El método de referencia para recuento de plaquetas es:

- A) Citometría de flujo y anticuerpos CD41 y CD61.**
- B) Impedancia.
- C) Citometría de flujo.
- D) Recuento en cámara de Neubauer.

251. ¿Qué afirmación no es cierta respecto a la pseudotrombopenia?

- A) Se debe a la aglomeración de plaquetas en presencia de EDTA
- B) Se corrige al utilizar otro anticoagulante distinto de EDTA
- C) Puede causar hemorragia si el recuento de plaquetas está por debajo de 20.000 plaquetas /microL**
- D) El examen del frotis sanguíneo establece el diagnóstico

252. ¿Qué marcador es esencial para detectar linfocitos T por citometría de flujo?

- A) CD3.**
- B) CD56.
- C) CD16.
- D) CD19.

253. La mutación JAK-2 constituye uno de los criterios mayores de diagnóstico en una de las siguientes enfermedades:

- A) Leucemia mieloide crónica
- B) Policitemia Vera**
- C) Alfa Talasemia
- D) Reacción leucemoide

254. La pseudotrombocitopenia causada por la adhesión de plaquetas a los neutrófilos esta relacionada con:

- A) Alteración de la proporción entre muestra y anticoagulante.
- B) Uso de EDTA como anticoagulante.**
- C) Nivel de fibrinógeno circulante.
- D) Ausencia genética de alguno de los factores de coagulación

255. Con respecto a la citometría de flujo, elija la opción INCORRECTA:

- A) Es una técnica de análisis celular multiparamétrico.
- B) Son necesarios anticuerpos monoclonales para reconocer antígenos celulares.
- C) La Organización Mundial de la Salud la considera indispensable para el diagnóstico y clasificación de las neoplasias hematológicas.
- D) Requiere una aglutinación previa de las células a estudiar.**

256. Se habla de pancitopenia cuando se presenta:

- A) Disminución de la serie plaquetar.
- B) Disminución de la serie eritroide y plaquetar.
- C) Disminución de la serie eritroide, plaquetar y leucocitaria.**
- D) Aumento de la serie eritroide, plaquetar y leucocitaria.

257. Se obtiene en el contador hematológico un recuento de plaquetas por debajo del límite de normalidad. Señale la respuesta correcta:

- A) La pseudotrombocitopenia inducida por EDTA (ácido etilendiamino tetraacético) es un fenómeno de aglutinación in vitro de las plaquetas.**
- B) El frotis no permite descartar las pseudotrombopenias por EDTA, macrotrombocitopenias o la presencia de esquistocitos
- C) "Satelitismo" plaquetario (agregación plaquetaria alrededor de los neutrófilos) no causa pseudotrombopenias.
- D) En caso de agregados plaquetarios (pseudotrombocitopenias) inducidos por EDTA se



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

debe hacer un recuento en sangre sin anticoagulante

258. ¿Con qué instrumento podemos obtener características antigénicas, bioquímicas y biofísicas de células individuales, medir el contenido en ADN de células y partículas, así como estimar el porcentaje de células que están en cada fase del ciclo celular?

- A) Microscopía confocal.
- B) Citometría de flujo.**
- C) Electroforesis invertida.
- D) Con ninguno de los anteriores.

259. ¿Dónde son menos abundantes los eosinófilos?

- A) En la sangre.**
- B) En la piel.
- C) En los pulmones.
- D) En el tubo gastrointestinal.

260. El sistema electrónico de un citómetro de flujo NO lo compone:

- A) Detector.
- B) Amplificador.
- C) El sistema informático.
- D) Todo lo anterior lo compone.**

261. Las manchas de Grumpech se ven en los frotis sanguíneos de pacientes con:

- A) Leucemia linfóide aguda.
- B) Alfa talasemia.
- C) Leucemia linfóide crónica.**
- D) Leucemia mieloide crónica.

262. El láser del citómetro de flujo produce una luz monocromática utilizada para la:

- A) Dispersión de la luz.
- B) Colección y análisis de pulsos.
- C) Inyección de fluidos.
- D) Excitación de los fluorocromos**

263. Al procesar la muestra en un contador automático, el técnico observa una pancitopenia. ¿Cuál de las opciones te parece la más inmediata?:

- A) Realizar frotis de sangre periférica.
- B) No tener en cuenta las alarmas en los distintos parámetros.
- C) Observar macroscópicamente la muestra y descartar la presencia de coágulos.**
- D) Solicitar reticulocitos.

264. ¿Cuál de los siguientes datos de laboratorio suelen aparecer disminuidos en la enfermedad de Hodgkin?:

- A) VSG
- B) Proteína C reactiva.
- C) Albúmina.**
- D) Inmunoglobulinas.

265. Ante la sospecha de una infección bacteriana, se hace un hemograma con el tubo con EDTA. ¿Qué alteraciones son compatibles con esta sospecha?

- A) Leucopenia, monocitosis y anemia
- B) Leucopenia, neutrofilia y trombocitopenia
- C) Leucocitosis, linfocitosis y trombocitopenia
- D) Leucocitosis, neutrofilia y trombocitosis**

266. En el desarrollo de los neutrófilos, cuál de las siguientes es la secuencia correcta:

- A) Promielocito-mieloblasto- cayado- metamielocito- segmentado
- B) Mieloblasto-metamielocito- mielocito- segmentado-cayado
- C) Mieloblasto-mielocito-metamielocito-cayado- segmentado**
- D) Promielocito- mieloblasto-segmentado- metamielocito-cayado

267. En una leucemia linfática crónica (LLC), ¿qué se puede observar en un frotis de sangre periférica?

- a) Un aumento de células plasmáticas
- B) Presencia de linfocitos grandes granulares y sombras de Gumprecht



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:   **Contrastedefases**

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

C) Linfocitos con el núcleo maduro y condensado, y sombras de Gumprecht

D) Bastones de Auer en el citoplasma de los linfocitos

268. También hacen un frotis sanguíneo y observamos los neutrófilos segmentados. ¿Qué característica podemos encontrar en presencia de una infección bacteriana?

a) Bastones de Auer

B) Hipogranulación del citoplasma

C) Vacuolización del citoplasma

D) Sombras de Gumprecht

269. ¿Qué tipo de método utilizan los autoanalizadores para obtener el recuento de células sanguíneas?

a) Citometría de flujo y citoquímica celular

B) Cromatografía de adsorción

C) Electroforesis

D) Impedancia eléctrica y dispersión de la luz

270. La célula de Sternberg-Reed ¿de qué enfermedad es característica?

A) Macroglobulinemia de Waldenström

B) Enfermedad de Hodgkin

C) Mieloma múltiple

D) Leucemia linfocítica crónica

271. En referencia a las posibles causas de un recuento disminuido de plaquetas en un hemograma, qué respuesta es INCORRECTA

a) Muestra coagulada en el tubo con EDTA-K3

B) Paciente con antecedentes de hepatopatía

C) Presencia de agregados plaquetarios EDTA-dependientes

D) Paciente con trombocitemia esencial

272. Actualmente, en las técnicas de inmunodiagnóstico se utiliza mucho la citometría de flujo. En referencia a esta técnica de análisis, ¿cuál de estas afirmaciones es FALSA?

a) Es necesaria la obtención de una suspensión celular.

B) Es necesario marcar las suspensiones con AcMo conjugados con fluorocromos.

C) Es necesaria la calibración del haz de luz led del citómetro de flujo.

D) Es necesario realizar la adquisición y análisis de datos.

273. En la pared de las plaquetas se encuentran muchas proteínas relacionadas con la coagulación sanguínea. ¿Cuál es el complejo receptor para el fibrinógeno, fibronectina y el factor Von Willebrand?

A) IIb-IIIa

B) Ib-IX

C) Ia-IIa

D) Ib-Ia

274. En la técnica citogenética de hibridación in situ con fluorescencia (FISH), para el estudio de los cromosomas en médula ósea de una Leucemia mieloide crónica se emplea la sonda de Reordenamiento BCR/ABL. ¿Qué anomalía cromosómica identifica?

A) t(15;17)

B) rob(14;21)

C) t(9;22)

D) t(8;21)

275. Señale la respuesta falsa de las siguientes afirmaciones sobre la tinción de PAS:

A) Es útil en la diferencia de las leucemias monocíticas

B) Es fuertemente positiva en la talasemia beta mayor

C) Es fuertemente positiva en los síndromes mielodisplásicos

D) Detecta la presencia de carbohidratos en las células

276. ¿Qué es la fórmula leucocitaria?

A) Un parámetro de la serie roja.

B) Un recuento diferencial de cada uno de los leucocitos presentes en sangre periférica.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

- C) Un test de aglutinación de leucocitos.
D) Ninguna es correcta.

277. En la fórmula leucocitaria, el menor porcentaje de leucocitos en un individuo sano corresponde a los:

- A) Basófilos.
B) Monocitos.
C) Neutrófilos.
D) Eosinófilos.

278. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las plaquetas es cierta?

- A) Son pequeñas figuras redondas u ovoides.
B) Su cantidad normal está entre 140.000 y 400.000 mm³.
C) Su vida media es de 8 a 13 días.
D) Todas estas afirmaciones sobre las plaquetas son ciertas.

279. Los leucocitos polimorfonucleares se clasifican en:

- A) Neutrófilos y linfocitos.
B) Neutrófilos, basófilos y eosinófilos.
C) Linfocitos y monocitos.
D) Neutrófilos, basófilos y linfocitos.

280. El receptor plaquetario para el Factor de Von Willebrand es:

- A) Factor III plaquetario.
B) Glucoproteína Ia/IIa
C) Glucoproteína Ib/IX
D) Ácido araquidónico.

281. ¿Qué trombofilia está producida por diferentes factores patológicos, farmacológicos o nutricionales, destacando la ingesta escasa de vitamina B12 y de ácido fólico?

- A. Hiperhomocisteinemia congénita.
B. Disfibrinogenemia.
C. Hiperhomocisteinemia adquirida.
D. Síndrome nefrótico.

282. La caracterización por citometría de flujo de los leucocitos de sangre periférica comprende la realización de una técnica de:

- A) Inmunofijación
B) Inmunoelectroforesis
C) Inmunofluorescencia
D) Immunoblot

283. ¿Cuál de las siguientes es causa de eosinofilia?

- A) Asma
B) Reacciones alérgicas
C) Parasitosis
D) Todas las anteriores son correctas

284. Los macrófagos son células:

- A) Del linaje linfoide
B) Del linaje mielóide
C) Neutrófilas
D) Basófilas

285. Al ir madurando, los blastos

- A) Aumentan de tamaño
B) Su cromatina se va condensando
C) Su citoplasma se haciendo más pequeño
D) Su citoplasma se va haciendo más basófilo

286. Si en un recuento de leucocitos aparecen niveles superiores a 25.000/mm³ ¿Se conoce cómo?

- A. Leucopenia.
B. Leucocitopenia.
C. Reacción hiperleucocitósica.
D. Ninguna de las anteriores.

287. El estado final de la maduración del linfocito B corresponde a:

- a) Linfocito grande.
B) Linfocito atípico.
C) Plasmocito.
D) Monocito vacuolado.

288. La alteración de May-Hegglin y el síndrome de Chédiak-Higashi pueden diferenciarse por la presencia de:



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases

RESPUESTAS DE EXÁMENES OFICIALES

Test tema 8.2: Fisiología y metabolismo leucocitario y plaquetar

- a) Células polimorfonucleares hipersegmentadas.
- B) Linfocitos y gránulos azurófilos.
- C) Disminución del número de gránulos agrandados.**
- D) Tinción citoquímica.

289. En condiciones normales, la cantidad de eritrocitos maduros producidos por una célula troncal multipotencial estimulada para producir normoblastos es de:

- a) 4.
- B) 8.**
- C) 16.
- D) 32.

Comentario. IMPUGNABLE. Se dividen por mitosis. La última que puede hacerlo es el eritroblasto policromatófilo. Serían 4 pasos, es decir 2^4 que son 16

290. De las siguientes, la primera célula precursora de los granulocitos neutrófilos es:

- a) Monoblasto.
- B) Mieloblasto.**
- C) Metamielocito.
- D) Promielocito.

291. ¿Cuál de las siguientes no puede ser causa de linfopenia?:

- a) SIDA.
- B) Linfoma.
- C) Infección vírica.**
- D) Tratamiento con inmunosupresores.

292. ¿Cuál es la translocación genética que da lugar a la leucemia mieloide aguda M3?

- a) t (15;17).**
- B) t (9;11).
- C) t (21;21).
- D) t (1;19).

293. En la clasificación de las leucemias mieloides agudas, ¿cuál corresponde con el tipo M6?:

- a) Leucemia mieloblástica aguda sin maduración.

- B) Leucemia mielomonocítica aguda.
- C) Eritroleucemia aguda.**
- D) Leucemia megacariocítica aguda.

294. Las trombopatías son:

- A) Alteraciones en el número de plaquetas.
- B) Alteraciones en la coagulación.
- C) Alteraciones en la función plaquetaria.**
- D) B y C son correctas.



Dudas en los:

Foros o



WhatsApp al 653 82 62 03

Academia Contraste de Fases

<http://formaciontecnicolaboratorio.com/>

Síguenos:



Contrastedefases